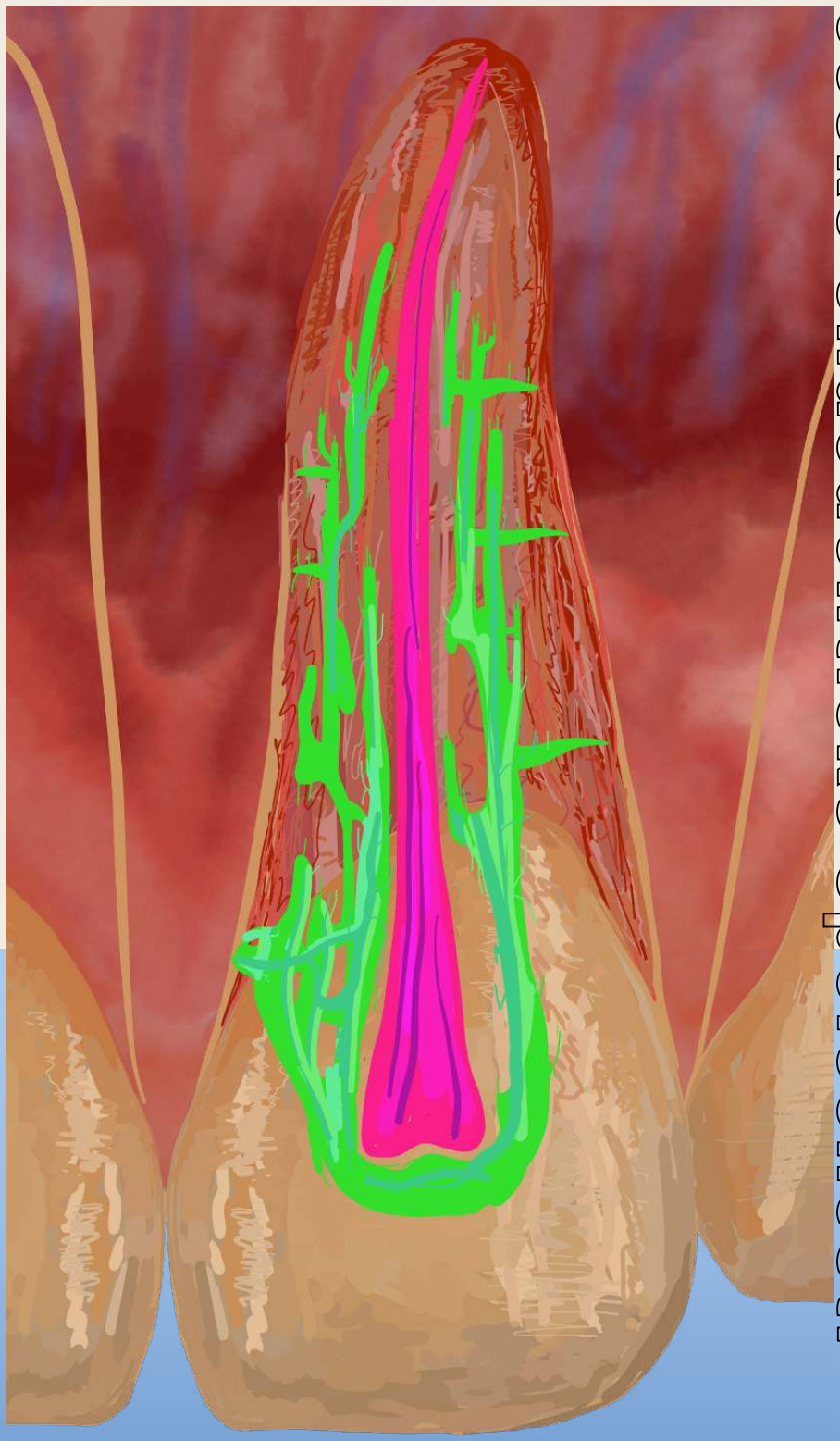
04

OBČASNÍK

první
2026



České endodontické společnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i v letošním vydání občasníku České endodontické společnosti se krátce ohlédneme za uplynulým rokem, nabídneme jedno odborné sdělení a připomeneme, co naše společnost připravuje do dalších měsíců.
V září minulého roku jsme se tradičně setkali na 17. výročním kongresu ČES. Hlavními zahraničními přednášejícími byli prof. David Sonntag a Dr. Christoph Zirkel, kteří se ve svých přednáškách zaměřili na optimalizaci trepanačního otvoru a glidepath a následně na klinické strategie při odstraňování nástaveb a výplňových materiálů během reendodontického ošetření. Dalšího zahraničního hosta jsme v Praze přivítali v březnu, kdy se prof. Nessrin Taha z Jordánska ve své přednášce věnovala zákrokům se zachováním vitality dřeně. Kromě toho ČES pořádala dvě výjezdní akce – říjnový workshop ve Skalici se Slovenskou endodontickou společností a červnové zasedání v Rychnově nad Kněžnou.
Odbornou část letošního občasníku věnující se resorpcím zubů a jejich managementu připravil MDDr. Vít Jiroušek. Prakticky pojatý článek provází čtenáře od diagnostiky a zhodnocení nálezu přes rozvahu o vhodném terapeutickém postupu až po jednotlivé možnosti ošetření. Věřím, že vám nabídne užitečný přehled této náročné problematiky a podněty využitelné v praxi.
Tento občasník dostáváte do rukou při příležitosti 18. výročního kongresu ČES, a proto jeho program není třeba dlouze představovat. Letošní podzim bude nicméně pro českou stomatologii skutečně mimořádný. Praha totiž během několika týdnů přivítá i světový kongres FDI a následně také výroční kongres European Prosthodontic Association. Doufám proto, že si z této mimořádné koncentrace odborných setkání každý vybere to své. A již nyní se můžeme těšit na další akce v příštím roce, třeba na březnovou přednášku prof. Josette Camilleri s názvem „Od MTA k biokeramickým sealerům“.
Přeji vám povedený letošní kongres a příjemné čtení.

Za redakci občasníku

Antonín Tichý



Zlatý sponzor

C.WITT DENTAL

rodentica®

Stříbrný sponzor

FENIX DENTAL

HENRY SCHEIN® DENTAL

JPS

Vystavovatel

EVERYDENT
KVALITA S RADOSTÍ A PERSPEKTIVOU

just Dent

medcem

Odonto

PATÁKOVO s.r.o.

Dentsply Sirona

VOCO



18. VÝROČNÍ KONGRES ČES

18.–19. 9. 2026 / PRAHA
Kongresové centrum
O2 Universum

8:00 - 9:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:00 - 10:30 **Prof. Matthias Zehnder**
DEZINFEKCE KOŘENOVÉHO SYSTÉMU

10:30 - 11:00 PAUZA

11:00 - 12:30 **Dr. Michael Solomonov**
BIOLOGICKÉ HODINY V ENDODONCII

12:30 - 13:45 OBĚD

13:45 - 14:30 **MUDr. Hana Zallmannová**
ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ PO ÚRAZE ZUBŮ

14:30 - 15:15 **MUDr. Roman Blahuta, Ph.D.**
OD ENDODONTIKÉHO DOSPIEVANIA KU ENDODONTICKEJ PLNOLETOSTIi

15:15 - 15:45 PAUZA

15:45 - 16:30 **MUDr. Ivan Martin**
PŘEPLNĚNÍ KOŘENOVÉHO KANÁLKU

16:30 - 17:00 **MDDr. Marek Řehoř**
BYPASS A LEDGE

Ze 17. kongresu České endodontické společnosti









Ve dnech 19.–20. září 2025 se v prostorách O2 universum v Praze uskutečnil 17. výroční kongres České endodontické společnosti (ČES). Také tentokrát byl program rozdělen do dvou dnů – pátek patřil praktickým workshopům a sobota přednáškám.

Hlavními zahraničními hosty letošního ročníku byli prof. David Sonntag a Dr. Christoph Zirkel z Německa. Páteční workshopy byly zaměřeny na ošetření úzkých a silně zakřivených kořenových kanálků a na reendodoncii. V sobotním dopoledním bloku pak oba přednášející zasadili tyto postupy do širšího klinického kontextu – od optimalizace trepanačního otvoru a vytvoření glidepath až po strategie odstraňování nástaveb a výplňových materiálů při reendodontickém ošetření. Dopolední blok tak kvalitně shrnul často opomíjené základní principy týkající se plánování přístupu do kořenového systému a jeho bezpečného zprůchodnění i opracování při primárním a reendodontickém ošetření.

Odpolední část programu zahájil MDDr. Tomas Kupec, který se věnoval výskytu zubních úrazů při sportu a možnostem jejich prevence. MUDr. Jiří Škrdlant společně s Ing. Martinou Škrdlantovou následně představili jednonávštěvovou endodoncii z léčebného i ekonomického pohledu. Součástí přednášky byla mimo jiné diskuse o indikacích jednonávštěvového ošetření a o roli hydroxidu vápenatého v současné endodontické léčbě.

Po přestávce vystoupil MDDr. Andrej Janiš s „Esejí o hlubokém kazu“. Problematiku pojal jako klinickou rozvahu nad různými možnostmi ošetření hlubokých kariézních lézí a argumenty, které hovoří pro selektivní či naopak neselektivní exkavaci kazu. Téma tak přirozeně otevřelo otázku, kde leží hranice mezi snahou odstranit kariézní tkáně a úsilím o zachování vitality zubní dřeně. Závěr kongresu patřil MDDr. Michalu Štefanatnému, Ph.D., který se prostřednictvím klinických případů zabýval otázkou, co dělat ve chvíli, kdy endodontické ošetření nevede k očekávanému výsledku.

Na loňský ročník letos navazuje již 18. výroční kongres ČES. Jeho hlavními zahraničními hosty jsou prof. Matthias Zehnder s přednáškou zaměřenou na dezinfekci kořenového systému a Dr. Michael Solomonov s tématem „Biologické hodiny v endodoncii“. Z domácích přednášejících se mimo jiné představí MUDr. Hana Zallmannová s přednáškou věnovanou úrazům zubů. Věříme, že i letošní program nabídne dostatek praktických podnětů, nových poznatků a příležitostí k odborné diskusi.

Radovan Žižka, Antonín Tichý

Přednáška prof. Nessrin Taha přinesla aktuální pohled na pulpotomie







Dne 27. 3. 2026 uspořádala Česká endodontická společnost (ČES) v pražském Ústavu molekulární genetiky AV ČR odbornou přednášku Prof. Dr. Nessrin Taha (Jordánsko) s názvem „Zákroky se zachováním vitality“. Akci uvedl a po celý den moderoval prezident ČES MDDr. Radovan Žižka, Ph.D. Odborný program přilákal téměř 200 účastníků z řad členů i nečlenů společnosti.

Již od časných ranních hodin probíhala ve vestibulu prezentace partnerů ČES. K příjemné atmosféře celého dne přispěl profesionální catering a káva připravovaná baristkami. Přednáška byla tradičně otevřena také nečlenům, členové ČES využili zvýhodněné ceny vstupného.

Odborný program byl rozdělen do tří bloků. V první části se Prof. N. Taha věnovala rozdílům mezi selektivní a neselektivní exkavací. Ve druhé pak samotnému technickému provedení pulpotomií. V závěrečné části se zaměřila na faktory, které ovlivňují jejich úspěšnost. Ve svém sdělení vycházela z výsledků dlouholeté klinické práce na rozsáhlém souboru pacientů. Prezentovaná data patří v současnosti k významným zdrojům informací o pulpotomiích u zubů s reverzibilní i ireverzibilní pulpitidou.

V průběhu dne zazněly také praktické poznámky k časovým intervalům hemostázy podle etiologie a vstupní klinické diagnózy, k volbě materiálu ukládaného do přímého kontaktu se zubní dření i k významu okamžité rekonstrukce zubu. Bylo patrné, že současný vývoj se dále odklání od hydroxidu vápenatého a více se přiklání ke kalciumsilikátovým materiálům, zejména k předmíchaným variantám.

Přednáška vyvolala různorodé reakce publika. Vedle pozitivního ohlasu byla v sále patrná i určitá odborná skepse, zejména ve vztahu k indikaci pulpotomií v souvislosti se selektivní či neselektivní exkavací. O to cennější byla závěrečná diskuze, která byla dlouhá, otevřená a věcná. Ukázala, že téma vitality zubní dřeně a pulpotomií zůstává v současné endodoncii mimořádně aktuální a zároveň odborně citlivé.

Přednáška Prof. Dr. Nessrin Taha ukázala, že i úzce zaměřené odborné téma může přitáhnout početné publikum a vyvolat živou odbornou diskuzi. Vedle samotného odborného obsahu nabídla akce také další příležitost k osobnímu setkání členů České endodontické společnosti i dalších kolegů se zájmem o moderní endodoncii.

Výjezdní zasedání ČES Skalice









Společné výjezdní zasedání ČES a SES ve Skalici
Ve dnech 24.–26. října 2025 se ve Skalici konalo společné výjezdní zasedání České endodontické společnosti a Slovenské endodontické společnosti. Navázali jsme tak na první setkání, které proběhlo před dvěma lety v Luhačovicích, a pokračovali v nově založené tradici.

Páteční program patřil odborným přednáškám. Čeští i slovenští kolegové se podělili o zkušenosti s méně častými klinickými situacemi a alternativními léčebnými postupy. Endodontickou část proložil speciální „výplachový protokol" – řízená degustace vín. Živá odborná i společenská diskuse pak pokračovala až do pozdního večera.

Protože nejen odborným programem je endodontista živ, vydali jsme se v sobotu společně na vinnou stezku, poznávat krásy Skalice a ochutnávat výsledky práce místních vinařů.

Další společné výjezdní zasedání obou společností se uskuteční 18.–20. června 2027 v Rožnově pod Radhoštěm. Už teď se těšíme!

Radovan Žižka

Zimní setkání v Sand in Taufers







Tradiční pozvánka do Jižního Tyrolska
Pod organizační taktovou MUDr. Michala Bumbálka jsme se v rodinné atmosféře shledali na dalším ročníku sportovně-rekreační události. Náramně vyšlo nejen počasí, nýbrž celé setkání. Příznivci lyžování, běžkování i bruslení si přijdou na své i v příštím roce a to v termínu 27. - 31. ledna 2027.

Jan Lapiš

Výjezdní zasedání ČES v Rychnově nad Kněžnou









Třetí červnový víkend se členové České endodontické společnosti sešli v Hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou na výjezdním zasedání. Komornější formát setkání nabídl dostatek prostoru nejen pro přednášky, ale především pro diskusi a neformální výměnu zkušeností.





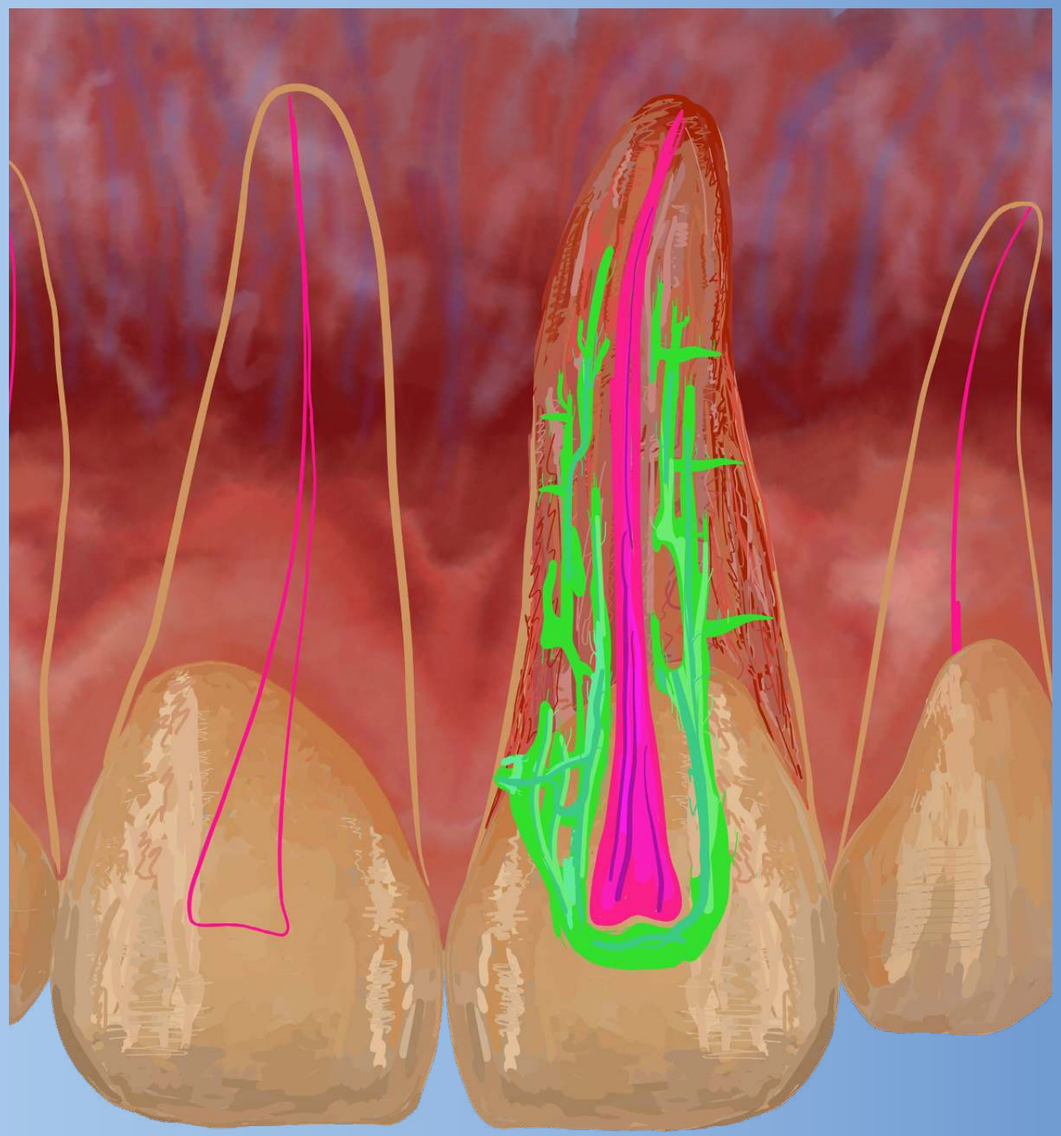
Páteční program začal po příjezdu a společné večeři workshopem MDDr. Antonína Tichého, Ph.D., jehož tématem byla umělá inteligence v zubním lékařství se zaměřením na endodoncii. Přednáška představila současné možnosti využití AI v klinické stomatologii, ale také její limity a úskalí. Vedle aplikací založených na analýze obrazových dat se věnovala i rychle se rozvíjejícím generativním nástrojům a možnostem jejich využití v každodenní praxi, vzdělávání a odborné práci. Endodontické příklady pak posloužily jako východisko k diskusi o tom, zda a do jaké míry mohou současné systémy lékaři skutečně pomoci.

Sobotní společenský program připravil místní rodák MDDr. Vít Jiroušek. Dopoledne začalo komentovanou prohlídkou rychnovského zámku, po níž následovala návštěva zrekonstruovaného kostela Nejsvětější Trojice a přilehlé zvonice. V kostele čekalo účastníky také vystoupení na varhany. Další zastávkou byl místní pivovar s historií sahající do 16. století, jehož prohlídku doplnila ochutnávka zdejších piv. Zpět k hotelu se část účastníků vydala pěšky přes les Včelný a kolem místního koupaliště. Po návratu do Hotelu Studánka se program znovu vrátil k endodoncii. Sobotní večer patřil prezentacím kazuistik členů společnosti, které vytvořily prostor pro společnou diskusi nad klinickými postupy a různými možnostmi řešení konkrétních případů. Odborný program uzavřel prezident ČES MDDr. Radovan Žižka přednáškou věnovanou pístové technice plnění kořenových kanálků. Stejně jako v pátek se následná diskuse protáhla do pozdních večerních hodin. Nedělní program již byl volnější a dal účastníkům možnost využít okolí hotelu a Orlických hor nebo se postupně vydat na cestu domů.

Vít Jiroušek, Antonín Tichý

Externí cervikální invazivní resorpce

MDDr. Vít Jiroušek



Resorpce zubů

Resorpce zubu je děj, při kterém dochází ke ztrátě tvrdých zubních tkání vlivem aktivity odontoklastů. Poranění tzv. protektivní vrstvy (tedy odontoblastů a predentinu uvnitř zubu a periodoncia na jeho povrchu) může vést ke vzniku různých druhů vnitřních nebo vnějších resorpcí. Některé resorpce jsou ireverzibilní a ve své podstatě patologické a na základě jejich typu a symptomatologie mohou vyžadovat naléhavé ošetření. Jiné jsou pouze přechodné, nebo může docházet k apozici mineralizované tkáně, a tudíž je můžeme pouze dlouhodobě sledovat.

V tomto článku se na základě kazuistik zaměříme na jeden druh resorpce – zevní (externí) cervikální invazivní resorpci (ECIR) včetně možností jejího řešení pomocí endodontického ošetření.

ECIR

Diagnostika

Diagnostika ECIR může být náročná. Klinicky se může větší resorpce projevit jako tzv. pink spot, v místě resorpce může docházet ke krvácení po sondáži a při použití zvětšení může být patrný vrůst tkání do zubu. I rentgenologicky má ECIR různé vzezření, vždy se zachováním stínu dřeňové dutiny a tzv. perikanalikulární vrstvy odolné resorpci (PRRS, z anglického Pericanalicular Resorption-Resistant Sheet, viz dále). Při podezření na ECIR je vhodné zhotovit detailní CBCT s malým field of view. V případě potvrzení diagnózy se poté CBCT snímek hodí i na plánování dalšího postupu.

Etiologie

ECIR vzniká, pokud je porušena protektivní vrstva cementu a zároveň působí dlouhodobější chronický stimul udržující resorptivní procesy v chodu, např. artikulační trauma, chronické záněty dásní, ortodontickou terapii či často zmiňované vnitřní bělení. Jak už název napovídá, nejčastěji k této resorpci dochází v krčkové oblasti zubu. Cement zde může být narušen vývojově, neboť při ukončení vývoje skloviny a počátku vývoje kořene nemusí dojít k úplnému překrytí dentinu cementem. K odstranění existujícího cementu může dojít i jinými způsoby, např. iatrogenně při scalingu, při extrakci sousedního zubu a kontaktu extrakční pákou s cervikální oblastí, při úrazu apod.

Fáze

ECIR probíhá v několika fázích, mezi které řadíme fázi iniciační, progresivní a reparativní. V iniciační fázi probíhá kontakt tkáně resorpce v nechráněným povrchem dentinu a k pronikání resorpce do zubu. Tomuto místu vstupu se anglicky říká point of entry. K další progresi resorpce je pak zapotřebí již zmíněný stimul, který resorpci podněcuje k šíření všemi strukturami zubu (dentinem, sklovinou i cementem) – progresivní fáze. Pokud naopak stimul odezní, resorpce se přestane šířit a resorptivní tkáň je postupně nahrazena vrůstající okolní tkání, nejčastěji kostí, jedná se o reparativní fázi.

Ankylóza

Jelikož při reparativní fázi vrůstá do resorptivního defektu okolní kost, může dojít k ankylóze tak, jak ji známe z traumatologie. Prozradí ji vysoký „kovový" poklep či diagnostické hodnoty Periotestu (Medizintechnik Gulden, Modautal-Brandau, Německo). Ankylóza v těchto případech není plošná, kostí tkáň lze odstranit při ošetření resorpce a ankylózu je tak možné rozrušit.

Vztah k pulpě

I když při terapii ECIR často potřebujeme ošetřit i endodont, nemá na rozdíl od jiných druhů resorpcí ECIR žádný původ v pulpě a taktéž se navzájem alespoň v prvních fázích resorpce vůbec neovlivňují. I když se resorpce rozšíří celou strukturou dentinu, prakticky nikdy nedojde k resorpci tenké vrstvy dentinu kolem pulpy, predentinu a vrstvy odontoblastů – vzniká již zmíněná PRRS. Proč k resorpci této vrstvy nedochází, není jasné a existuje více vysvětlení, např. jiná úroveň mineralizace, vnitřní faktory v tkáni nebo gradient kyslíku z pulpy. Jelikož resorpce může na rentgenovém snímku často simulovat kaz, může nám PRRS pomoci v diagnostice ECIR, neboť je rentgenologicky často dobře patrná. V pokročilejších fázích může dojít k infekci resorpce a tím i endodontu. U endodonticky ošetřených zubů se ECIR šíří rychleji.

Klasifikace

Heithersay ve své 2D klasifikaci rozděluje na základě intraorálních snímků do čtyř tříd.

Obr. 1 - Heithersayova klasifikace.

Patel používá 3D klasifikaci na základě CBCT a dělí resorpci podle koronoapikálního rozsahu, dle cirkumferentního šíření a dle vzdálenosti resorpce od pulpy.

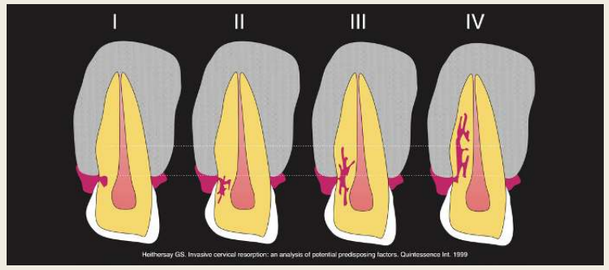
Ani jedna klasifikace však přímo nezohledňuje pozici resorpce ani velikost point of entry, jež jsou dle mých zkušeností důležité pro plánování ošetření – viz dále.

Co s tím?

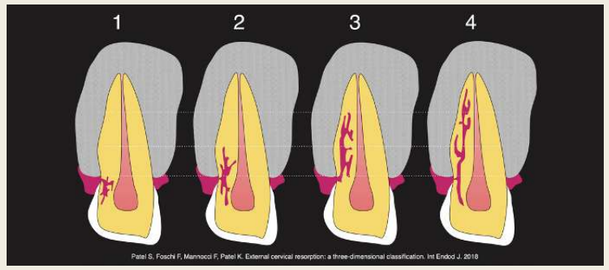
Pokud na základě analýzy CBCT snímku a klinického vyšetření dojdeme k závěru, že by resorpce byla pro ošetření špatně přístupná, je rozsáhlá, eliminovali jsme chronický stimul, na rentgenologickém vzezření resorpce převažuje reparativní fáze a případná ankylóza způsobená vrůstem kosti nepředstavuje problém, je možné resorpci pouze sledovat a neošetřovat – s cílem nenapáchat více škod než užitku. Z literatury však vyplývá, že resorpce mají v čase tendenci se zvětšovat.

Ošetření

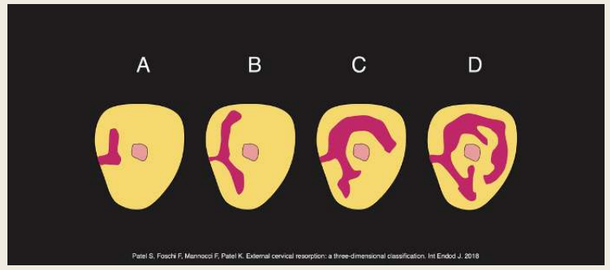
Ošetření resorpce spočívá v jejím kompletním mechanickém, případně chemickém odstranění. K tomuto účelu je nutné si k resorpci zajistit přístup. Můžeme využít buď vnější, chirurgický přístup, nebo přístup vnitřní skrz strukturu zubu s případným ošetřením endodontu. Volba přístupu závisí především na lokalizaci resorpce a point of entry, vzdálenosti resorpce od pulpy a velikosti point of entry. Podle literatury má vnější přístup má vyšší úspěšnost než přístup vnitřní, proto bychom měli u hraničních případů, u kterých jsou možné obě varianty ošetření, preferovat přístup vnější.



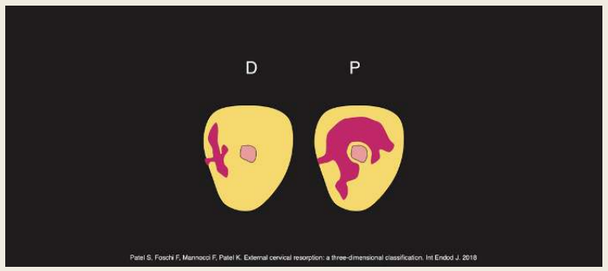
Obr. 1 - Heithersayova klasifikace



Obr. 2 - Patelova klasifikace



Obr. 3 - Patelova klasifikace



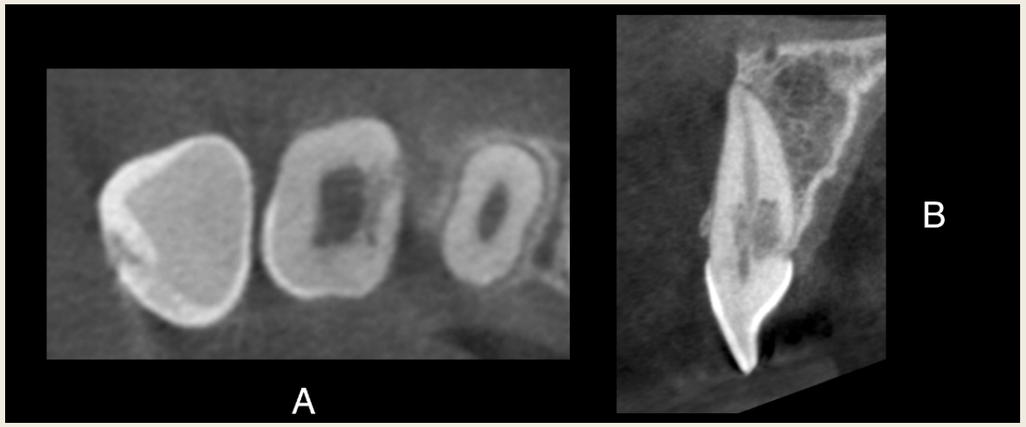
Obr. 4 - Patelova klasifikace

Vzdálenost resorpce od pulpy

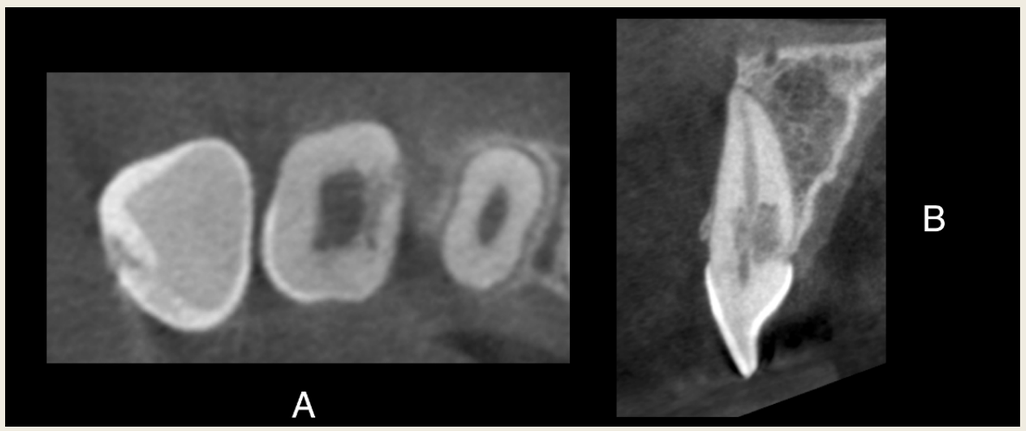
Vnitřní přístup s sebou často nese nutnost ošetřit i endodont, ač primárně s tímto typem resorpce nemá žádný vztah. Endodontické ošetření tedy není kauzální terapie resorpce, je však často nevyhnutelné k zajištění přístupu pro odstranění resorpce. Pokud je vzdálenost resorpce od pulpy velká, bylo by primárně vhodné resorpci řešit vnějším přístupem, abychom se vyhnuli nutnosti ošetření endodontu. Je-li naopak resorpce rozsáhlá a v těsné blízkosti pulpy, je vnitřní přístup vhodnější. Pokud bychom totiž zvolili u takové resorpce vnější přístup, je možné, že by bylo nutné nejprve resorpci ošetřit chirurgicky a následně ošetřit i endodont – tedy že by byla nutná kombinace obou přístupů.

Point of entry

V terapii hraje point of entry zásadní roli. Pokud je malý, dá se resorpce většinou řešit vnitřním přístupem, pokud je velký, lépe se řeší přístupem zevním. Čím je resorpce větší, tím roste šance, že je přítomno více point of entry, které pak mohou být klinicky hůře detekovatelné a řešitelné, což může být jedním z důvodů selhání ošetření resorpce. Jelikož tento článek směřuje do endodontického časopisu, bude dále popsán pouze vnitřní přístup s terapií endodontu a vnější přístup bude přenechán kolegům chirurgům.



Obr. 5 (a) - Řez z CBCT s aproximální lokalizací point of entry u horního prvního moláru.
Obr. 5 (b) - Řez z CBCT s palatinální lokalizací point of entry u horního středního řezáku.



Obr. 6 - Řezy z CBCT snímku s naznačením ideálního trepanačního otvoru, kterým si zajistíme dobrý přístup k resorptivní tkáni.

Plánování vnitřního přístupu

CBCT snímek je vhodný nejen k diagnostice ECIR, ale především pro plánování ošetření této resorpce. Na základě CBCT je vhodné naplánovat ideální design trepanačního otvoru, abychom zajistili dobrý přístup jak pro odstranění resorpce, tak i pro ošetření endodontu. Pro co nejkonzervativnější přístup je možné využít navigovanou endodoncii.

Ošetření endodontu

Pulpa je většinou při terapii ECIR zdravá a je tedy často možné odstranit pouze takovou část pulpy, kterou odstranit musíme pro management resorpce. Pokud se resorpce nešíří výrazně apikálně, můžeme například provést hlubokou pulpotomii ve vstupech do kořenového systému. Pokud je pulpa již postižena či resorpce zasahuje více apikálně, přistoupíme ke kompletnímu endodontickému ošetření.

Odstranění resorptivní tkáně

Jakmile si zajistíme vhodný přístup k resorpci, je možné ji odstranit. Přehled však často komplikuje výrazné krvácení z bohatě vaskularizované resorptivní tkáně.

K rychlé koagulaci tkáně resorpce můžeme využít např. vysokofrekvenční proud s tenkou koncovkou či silnou kyselinu nebo zásadu – klinicky se nejvíce osvědčilo použití kyseliny trichloroctové. Resorpce není často pouze jeden velký shluk tkáně, nýbrž často probíhá v malých kanálcích do struktury zubu, čímž je použití vysokofrekvenčního proud limitované. Kyselinu trichloroctovou je vhodné nanášet jen ve velmi malém množství, např. na mikroštětečku, abychom zamezili jejímu průniku do periodoncia, kde by taktéž došlo ke koagulaci a následné nekróze tkání.

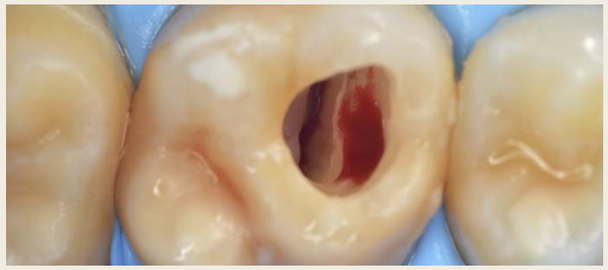
Rychlá koagulace jde ruku v ruce s hemostázou a koagulovanou tkáň můžeme poté lépe odstranit pomocí tvrdokovových vrtáčků na dlouhém dříku (EndoTracer Bur, Mounce Bur apod.) nebo diamantovaných ultrazvukových koncovek. Vrtáčky jsou efektivní na odstranění největšího množství tkáně, diamantované koncovky jsou šetrnější a můžeme



Obr. 7 - RTG snímky zubu před a po ošetření - provedena pulpotomie a ošetření resorpce.



Obr. 8 - RTG snímky zubu před a po ošetření - provedeno endodontické ošetření a ošetření resorpce.



Obr. 9 - Fotografie s krvácející resorpcí.



Obr. 10 - Stav po koagulaci resorptivní tkáně.

je využití k dokončení preparace. Většinou je nutné tyto kroky – aplikaci kyseliny a následné mechanické odstranění – několikrát zopakovat, než dosáhneme úplného odstranění resorpce.

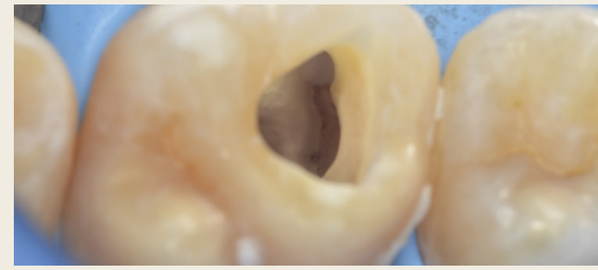
Pokud máme v plánu provést pulpotomii a zachovat část pulpy vitální, není vhodné používat kyselinu trichloroctovou. V takovém případě lze k chemickému rozpuštění resorptivní tkáně použít chlornan sodný, který běžně využíváme v rámci endodontického ošetření či při pulpotomii. Vhodné je i použití hydroxidu vápenatého, jehož vysoké pH inhibuje aktivitu klastických buněk. Hydroxid vápenatý zároveň dobře difunduje do všech struktur resorpce, vyžaduje však ošetření ve dvou fázích – jeho suspenzi aplikujeme na dobu nejméně jednoho týdne.

Krytí místa vstupu a dostavba

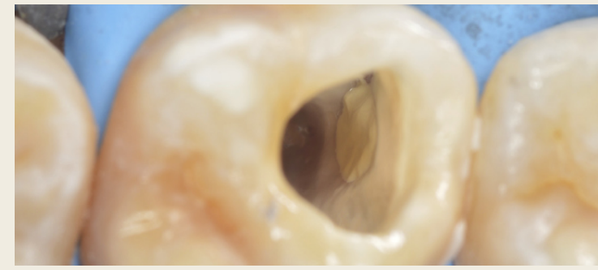
V další návštěvě již většinou k žádnému krvácení nedochází a je možné point of entry překrýt. Pokud je point of entry malý a můžeme zajistit suché pracovní pole, můžeme ho spolu s trepanačním otvorem uzavřít pouze adhezivně jako po běžném endodontickém ošetření. Pokud je point of entry rozsáhlejší a nelze zajistit suché pracovní pole, je vhodné využít materiály tolerující vlhkost – kalciumsilikátové cementy. Ty při tuhnutí taktéž produkují hydroxid vápenatý a způsobují již zmíněnou krátkodobou inhibici osteoklastů. Cement je nutné aplikovat v dostatečné vrstvě (cca 3 mm). Pokud je defekt na stěně, není jednoduché dostatečnou vrstvu materiálu vytvořit a v těchto případech je vhodné vyplnit např. celé dno dřeňové dutiny, abychom dostatečné vrstvy materiálu dosáhli.

Pokud jsme při ošetření resorpce provedli pulpotomii, využijeme stejný materiál jak pro krytí místa vstupu resorpce, tak pro krytí zbylé pulpy. Vyčkáme tuhnutí cementu nebo cement překryjeme např. samoadhezivním kompozitem a trepanační otvor zrekonstruujeme jako při běžném endodontickém ošetření.

Vít Jiroušek



Obr. 11 - Po mechanickém odstranění resorpce.



Obr. 12 - Stav po vyplnění defektu.

Literatura

1. Heithersay GS. Invasive cervical resorption: an analysis of potential predisposing factors. Quintessence Int. 1999; 30(2):83-95.

2. Patel S, Kanagasingam S, Pitt Ford T. External cervical resorption: a review. J. Endod. 2009; 35(5):616-25. doi: 10.1016/j.joen.2009.01.015

3. Mavridou AM, Hauben E, Wevers M, Schepers E, Bergmans L, Lambrechts P. Understanding External Cervical Resorption in Vital Teeth. J. Endod. 2016; 42(12):1737-1751. doi: 10.1016/j.joen.2016.06.007

4. Mavridou AM, Hauben E, Wevers M, Schepers E, Bergmans L, Lambrechts P. Understanding external cervical resorption patterns in endodontically treated teeth. Int. Endod. J. 2017; 50(12):1116-1133. doi: 10.1111/iej.12744

5. Mavridou AM, Bergmans L, Barendregt D, Lambrechts P. Descriptive Analysis of Factors Associated with External Cervical Resorption. J. Endod. 2017; 43(10):1602-1610. doi: 10.1016/j.joen.2017.05.026

6. Patel S, Foschi F, Mannocci F, Patel K. External cervical resorption: a three-dimensional classification. Int. Endod. J. 2018; 51(2):206-214. doi: 10.1111/iej.12824.

7. Patel S, Mavridou AM, Lambrechts P, Saberi N. External cervical resorption-part 1: histopathology, distribution and presentation. Int. Endod. J. 2018; 51(11):1205-1223. doi: 10.1111/iej.12942

8. Patel S, Foschi F, Condon R, Pimentel T, Bhuva B. External cervical resorption: part 2 - management. Int. Endod. J. 2018; 1(11):1224-1238. doi: 10.1111/iej.12946

9. Patel S, Brown J, Semper M, Abella F, Mannocci F. European Society of Endodontology position statement: Use of cone beam computed tomography in Endodontics. Int. Endod. J. 2019; 52(12):1675-1678. doi: 10.1111/iej.13187

10. Irinakis E, Haapasalo M, Shen Y, Aleksejuniene J. External cervical resorption - Treatment outcomes and determinants: A retrospective cohort study with up to 10 years of follow-up. Int. Endod. J. 2022; 55(5):441-452. doi: 10.1111/iej.13717

11. Mavridou AM, Rubbers E, Schryvers A, Maes A, Linssen M, Barendregt DS, Bergmans L, Lambrechts P. A clinical approach strategy for the diagnosis, treatment and evaluation of external cervical resorption. Int. Endod. J. 2022; 55(4):347-373. doi: 10.1111/iej.13680

12. Patel S, Krastl G, Weiger R, Lambrechts P, Tjäderhane L, Gambarini G, Teng PH. ESE position statement on root resorption. Int. Endod. J. 2023; 56(7):792-801. doi: 10.1111/iej.13916

13. Nosrat A, Dianat O, Verma P, Levin MD, Price JB, Aminoshariae A, Rizzante FAP. External Cervical Resorption: A Volumetric Analysis on Evolution of Defects over Time. J. Endod. 2023; 49(1):36-44. doi: 10.1016/j.joen.2022.10.010

14. Patel S, Abella F, Patel K, Lambrechts P, Al-Nuaimi N. Clinical and radiographic features of external cervical resorption - An observational study. Int. Endod. J. 2023; 56(12):1475-1487. doi: 10.1111/iej.13968

Koncem srpna se v Austrálii konal 16. světový endodontický kongres IFEA. Česká endodontická společnost měla své zastoupení v podobě MDDr. Marka Řehoře, který vystoupil se svou přednáškou Ledge & Bypass.

Kongres IFEA WEC v Sydney se podle mě celkově opravdu vydařil. Už jen účast téměř 1000 lidí z 58 zemí ukázala, že o akci byl obrovský zájem, a po odborné i organizační stránce bylo všechno zvládnuté velmi dobře. Program byl nabitý, bylo z čeho vybírat a musím pochválit i občerstvení, což je samozřejmě jeden z důležitých parametrů každého kvalitního kongresu. A jako bonus – Sydney a Austrálie obecně jsou skvělé místo, kam se kvůli kongresu nechat poslat.

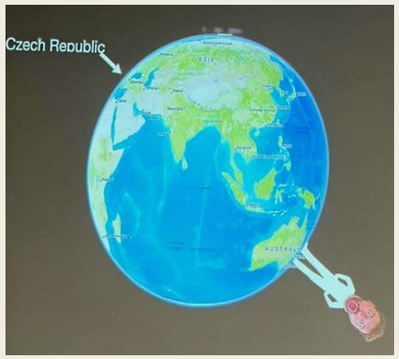
Součástí kongresu bylo také zasedání zástupců jednotlivých národních endodontických společností v rámci IFEA AGM. Bylo zajímavé slyšet, jak fungují společnosti v dalších zemích a kam se chce IFEA v následujících letech posouvat. Představen byl nový web, další rozvoj odborného obsahu a newsletteru a také plány na následující kongresy. Příští WEC se uskuteční v roce 2028 v New Yorku společně s AAE, ještě předtím nás ale čeká další AGM během ESE 2027 v Římě.

Pro mě osobně byla samozřejmě největší událostí vlastní přednáška na téma Ledge & Bypass. Nervozita byla větší, než bych si přál, ale nakonec se zaplnila více než polovina sálu a následné reakce byly velmi pozitivní, takže z toho mám velkou radost. Celkově pro mě byl kongres skvělou zkušeností – odborně přínosný, organizačně povedený a zároveň příležitost potkat kolegy z celého světa.

Marek Řehoř







V dalším plánu letošního roku

18. - 19. 9. 2026	18. výroční kongres ČES, O_2 universum Praha
22. - 23.9.2026	Výjezd na kurz Prof. Grandini (Maillefer)

Data k uložení v roce 2027

23. 1. 2027	Volební členská schůze ČES, Praha
19. 3. 2027	Dr. Josette Camilleri, Praha
18. - 20. 6. 2027	Výjezdní zasedání ČES a SES, Rožnov pod Radhoštěm
17. - 18. 9. 2027	19. výroční kongres, Praha

Název	Občasník ČES
Autoři	MDDr. Vít Jiroušek, MDDr. Jan Lapiš, MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MSc., PhDr. Iva Žáková
Vydavatel	Česká endodontická společnost, z.s., Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Datum vydání	2026
Autorská práva	Česká endodontická společnost, z.s., Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Vyrobila	Tiskárna Kartis+Co s.r.o., Borovského 14/717, 734 01 Karviná - Ráj